

身体拘束等 実施・早期解除フローチャート

身体拘束等は「患者の生命または身体を保護するため、緊急かつやむを得ない場合には認められる。患者に、以下に示すような状態があり、且つ、身体拘束等が認められる3つの要件①切迫性②一時性③非代替性の、すべての要件を満たす場合に限り、下記のフローチャートに沿って判断、実施する。

- ①治療上でチューブ・カテーテル・ドレーン等の管理が必要であるが自己抜去等により生命の危機及び治療上著しい不利益が生じる場合
- ②精神運動興奮による不穏が強度で治療に協力が得られない、自傷・他害の危険性が高い場合
- ③ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合
- ④行動障害が頻回かつ切迫している場合
- ⑤検査・手術・治療で抑制が必要な場合
- ⑥その他の危険行動(自殺・離院・離棟等)の危険性がある場合

医師・看護師等で身体拘束等の必要性を検討し、上記の問題行動を明確にする。
身体拘束等開始時のアセスメント(様式1 マニュアルを参照)。

「身体拘束等」が必要と判断したら、
医師は指示簿に「身体拘束等開始」の指示
を記載する。

夜間等緊急時

- ①口頭で家族へ説明・承諾を得る。
- ②カルテに記載する。③
- ③同意書は後日記載してもらう。

医師は患者・家族へ「身体拘束等」の必要性
を説明し、同意書を取得する。

身体拘束等開始

身体拘束等実施中
①身体拘束等の継続・解除の評価
②身体拘束等実施中の観察・記録

- ①身体拘束等の継続・解除については毎日評価を行う。
(様式5「身体拘束等の必要性」 マニュアルを参照)
- ②身体拘束等実施中は、経過表の観察項目の欄に記入
欄を設け、毎日観察したことを記載する。
- ③経過表で、使用器具の状況や認知症、抑制の実施の
状況を、毎日確認する。
- ④1週間に1回以上は医師や多職種とともに「身体拘束
等実施中の評価」(様式5「評価」、マニュアルを参照)
を用いて解除が可能かどうかを判断する。
* 早期解除の検討
- ⑤カンファレンス記録や経過記録を使って、十分に記録
する。

身体拘束等の必要はないと医師が判断したら、評価した内容をカルテに記載し、
医師は指示簿に「身体拘束等中止」の指示を記載する。